Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Perte de connaissance / Malaise

Malaise, perte de connaissance brève, personne retrouvée inconsciente qui respire : protéger, mesurer, alerter. Adulte et enfant (IME).

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne respire pas normalement (→ RCP), ne se réveille pas, douleur thoracique, signes d'AVC, convulsion > 5 min, trouble de conscience brutal.

1 · Je sécurise

- Ne répond pas : respiration vérifiée **10 s** ; anormale → protocole « Arrêt cardio-respiratoire ».
- Inconscient qui respire : **PLS** ; femme enceinte ou personne obèse : sur le **côté gauche**.
- Conscient : **allongé** (assis s'il respire mal) ; je ne le relève pas tout de suite.
- Après une chute : pas de PLS ; s'il vomit, le tourner sur le côté, tête-cou-tronc alignés.

2 · J'observe et je mesure

- Répond-il ? Respire-t-il normalement ? Heure de début, durée.
- Pouls, **TA aux deux bras**, SpO2, FR, T° (seuils : « Fiche 0 — Signes de gravité »).
- **Glycémie capillaire** (AS/AP) : < 0,70 g/L → protocole « Hypoglycémie ».
- Douleur thoracique, essoufflement, palpitations, **visage, bras, parole** (AVC) ?
- Circonstances : lever, effort, repas, toux, nouveau médicament ; choc à la tête ?

3 · J'agis

- Desserrer les vêtements, couvrir, rassurer ; je reste auprès de lui.
- Je préviens l'IDE : l'**ECG** est fait par l'IDE et transmis au médecin.
- Récupération complète : rester allongé, recontrôler TA et pouls ; relever **progressivement, à deux**.
- Protocole individuel / PAI (épilepsie, diabète) : je l'applique.

Je ne fais pas

- Faire boire, manger ou prendre un médicament s'il est somnolent ou avale mal.
- Le laisser seul, même après récupération.
- Le relever d'un coup ou le faire marcher tout de suite.
- Mettre en PLS après une chute avec douleur du cou ou du dos.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Ne se réveille pas, ou reste confus ou somnolent.
- Douleur thoracique, essoufflement, signes d'AVC (même régressifs), convulsion > 5 min.
- Chiffre du niveau 2 (« Fiche 0 ») et **IDE non joignable** tout de suite.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- Tout malaise, **même récupéré** : ECG par l'IDE, avis médical.
- Chiffre du niveau 2 (« Fiche 0 ») : IDE **sans délai**.
- Malaises répétés, traitement récemment modifié, chute associée.

Je surveille et je trace

- Recontrôler conscience, TA, pouls ; tout changement → IDE ou 15.
- Tracer : heure, durée, circonstances, paramètres, glycémie, récupération, qui a été prévenu.
- Chute associée : protocole « Chute » ; choc à la tête : « Traumatisme crânien ».

Mention de sécurité

Inconscient + respiration anormale = arrêt cardiaque : RCP et DSA. Un malaise qui récupère n'est pas banal : glycémie, paramètres, IDE.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : DGSCGC, recommandations PSC1 : malaises, perte de connaissance, PLS (12/2023) ; ERC Guidelines 2025 First Aid et Adult BLS (Resuscitation 2025;215) ; ARS IDF/SGGIF, fiche « perte de connaissance » (2016) ; arrêté du 26/06/2026 (ECG : rôle propre IDE ; glycémie : AS/AP).

Réf. DOTR-AS-MALAISE | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature